

Conversion AMI – IA : (en jaune = signification) (en bleu = abréviation)

Table des matières

1.	Cas 1 : 22/12/XX IlotE1 T	2
2.	Cas 2 : Mr V C2 10/05/XX	9

1. Cas 1 : 22/12/XX IlotE1 T

Validation Cs (consultation) : Oui (Consultation validé = geste opératoire possible)

A JEUN Commentaire (Règle de jeun, classiquement 6h pour les solides avant date opératoire, ou horraire de convocation / 2h avant horraire de convocation pour les liquides claires : eau, jus de fruit sans pulpe, thé, café) : a jeun 6h avt op solides et 2h avt op liquides clairs

alcool (Consommation d'alcool, permet de dépister d'éventuel complication per/post-op lié au sevrage OH (= alcoolique)) : Occasionnel

allergies : Non Connue

Score Apfel (score APFEL : score de 0 à 4 pour dépister les risques de NVPO = nausées vomissements post opératoire) : 3

Appareil auditif : Normal

Asa (Score de condition physique du patient, allant de 1 à 5 ou 1 étant le patient jeune en bonne santé et 5 un patient moribond dont l'espérance de vie de dépasse pas 24h / Un score plus élevée indique un risque augmenté de complication et de mortalité opératoire). : 1

Atcd (antecedents) intubation difficile : Non (en l'occurrence, le patient a déjà été intubé sans difficulté)

ATCD VAM (ventilation au masque / lesquelles la ventilation au masque pourrait être difficile) Permet de dépister les patients chez difficile : Non

BMI (Body Mass Index / Poids divisée par Taille au carré / Utile pour dépister une dénutrition ou une obésité) : 19,17

Allergènes (Allergène pouvant être acariens, poussières ... Utile pour dépister certain terrain atopique, pouvant entraîner par exemple de l'asthme) : RAS (Rien à signaler)

Clinique (Type de réaction provoqué par les allergies ou allergènes, du simple mal de gorge au choc anaphylactique) : RAS

Date intervention (Date opératoire programmé, choisit par le chirurgien) : 25/01/2023

Date_Coag (date à laquelle le bilan de coagulation a été réalisé) : 06/12/2022

Diagnostic opératoire (fait par le chirurgien et motivant l'indication) : IOA (infection ostéo articulaire) sur PTH (prothèse totale de hanche)

DTM (Distance thyro-mentonnière, un critère d'intubation difficile) : Oui

estomac plein (recherché pour toute intervention chirurgicale, si oui, risque d'inhalation pendant la mise en condition de l'anesthésie générale)
: Non

Etat dentaire (recherche de signe de mauvais état bucco-dentaire, l'intubation étant elle-même à risque de fracas dentaire) : Bridge sup droit/Pas de dents mobiles

état veineux D (Droit) (Dépistage d'un bon état des veines périphériques et de la facilité (ou non) de mettre une perfusion) : Bon

état veineux G (Gauche) : Bon

Geste opératoire (conditionné par le diagnostic fait par le chirurgien et définie clairement le geste associé au bloc opératoire) : Membre inférieur (Lavage articulaire (hanche/Gauche))

HDLM (Histoire de la maladie / Brièvement, explique l'histoire du patient avant l'apparition du diagnostic) : A glissé sur une plaque de verglas.

Autonome sur tous les plans, parker 9. (score d'autonomie)

désunion cicatrice et écoulement a 1 mopsis avec hémoc (hémocultures / recherche d'infection dans le sang) +

a cocci + (forme du microorganisme identifiée)

PCR (Réaction en chaîne par Polymérase / technique de laboratoire) covid neg

heure intervention (horaire prévu pour le bloc opératoire) :
07:30

Informations Consentements (liste les items énumérés à l'oral et/ou par écrit lors de la consultation d'anesthésie) : Technique d'Analgésie, Technique

d'Anesthésie, Intubation, Risque Anesthésie, ALR (Anesthésie Loco-Régionale / Technique d'anesthésie visant à endormir une (ou plusieurs) partie du corps)

Modalité (Définit l'urgence ou non du geste opératoire, peut être urgent, ½ urgent, programmé (dans la majorité des cas)) : 1/2 urgente

Intervenant (Indique l'opérateur de la chirurgie)
: Dr XXXXX.

Lee (outil utilisé pour évaluer le risque de complications cardiovasculaire lors de chirurgie non cardiaque de 0 à 5, 5 étant le score le plus à risque): 0

Lentilles contact : Non

Mallampati (méthode pour anticiper les difficultés d'intubation selon la morphologie, de 1 à 4, 4 étant le plus à risque) : 1

Mecanisme IM (insuffisance mitrale / maladie du cœur (souffle) pouvant être liée à divers mécanisme) : ??? (non remplis, parfois car non connus voir absence)

Médecin Sénior (Médecin anesthésiste réanimateur responsable de la consultation d'anesthésie) : Pr XXX

Morsure lèvre supérieure (un des critères prédictif d'intubation difficile) : NE (non évalué)

ouverture de bouche (un des critères prédictif d'intubation difficile) : Oui

piercing : Non

poids : 42,0

post-opératoire (lieu où se déroulera la période post-opératoire immédiate, pouvant être SSPI, réanimation, unité de soins intensifs ...) : SSPI (Salle de Surveillance Post-Interventionnelle)

Prieur (un des critères prédictif d'intubation difficile) : NE

Rachis cervical (un des critères prédictif d'intubation difficile) : Oui

rgo (Reflux Gastro-Oesophagien / Remontée acide, information pouvant modifié le protocole d'anesthésie) : Non

RP (Radiographie Pulmonaire / Evaluation du parenchyme pulmonaire) : Normale

Scanner/Echo (Echographie) / (Examen para-clinique) : ???

sevrage alcool : Non

sevrage tabac : Non

sevrage toxicomanie : Non

tabac (Evaluation de la consommation tabagique, le sevrage étant toujours à rappeler) : Non

taille : 148

Terrain (Fait partie de la catégorie « allergie », permet de dépister des terrains atopiques avec une sensibilité augmentée à certaine substance) : RAS (Rien à signaler)

Transfusion (Recherche antériorité de transfusion) : Non

type d'anesthésie (Technique d'anesthésie choisie, peut-être une anesthésie générale, une anesthésie loco régional, une sédation seul ...) : AG (Anesthésie générale)

type intubation ventilation) : IOT (Intubation Orotrachéale) (Technique permettant d'assurer la ventilation)

VAM obésité masque difficile) : Non (un des critères prédictif de ventilation au masque difficile)

VAM ronflement masque difficile) : Oui (un des critères prédictif de ventilation au masque difficile)

VAM barbe masque difficile) : Non (un des critères prédictif de ventilation au masque difficile)

VAM édentation masque difficile) : Non (un des critères prédictif de ventilation au masque difficile)

VAM âge>55 ans masque difficile) : Oui (un des critères prédictif de ventilation au masque difficile)

PIT (Poids idéal théorique / ajuster le poids « idéal ») : 41,50 (Formule prenant en compte la taille pour ajuster le poids « idéal »)

PC (Poids corrigé/ ajuster le poids « idéal »): 41,7127 (Formule prenant en compte la taille pour ajuster le poids « idéal »)

score iot (Score total dépistant la difficulté lors de l'intubation, nb à partir de 2 : possiblement difficile) : 0

score iot NE (Non évaluable) : 2

score vam NE : 0

Commentaire_iot_vam (Information plus détaillé sur l'évaluation clinique, rempli par le médecin) : cormack 1 en 2022 (Classification clinique morphologique lors d'une précédente intubation, de 1 à 4).

score vam adulte (Score total dépistant la difficulté lors de la ventilation au masque facial, nb à partir de 2 : possiblement difficile) : 2

BNP (2) (paramètre sanguin) : 76

C.R.P. (2) (paramètre sanguin) : 4.6

Coagulation (2) (paramètre sanguin) : Normal

Coeur : auscultation (2) (Recherche à l'auscultation d'anomalie cardiaque) : Souffle systolique Ao (Aortique) – BDC (Bruit Du Cœur) réguliers

Coeur : signes fonctionnels (Recherche à l'interrogatoire de signe de défaillance cardiaque) (2 : Aucun - Met > 4 (équivalent métabolique / évaluer la capacité fonctionnel d'un patient) - Rando 10-20 km hebdo

Créatinine (2) (paramètre sanguin) : 55

E.C.G. (Electro cardiogramme / Examen para-clinique du cœur) : Normal

E.F.R. (2) (Epreuve fonctionnel respiratoire / Evaluation fonction pulmonaire) : ???

Fibrine (paramètre sanguin) : 3.6

Hémoglobine (2) (paramètre sanguin, reflet de la quantité de sang) : 13.7

INR (paramètre sanguin) : 1

K+ (2) (paramètre sanguin) : 4

Leucocytes (2) (paramètre sanguin) : 14

Na (2) (paramètre sanguin) : 141

Péricarde (évaluation cardiaque) : ???

Plaquettes (paramètre sanguin) : 307

Poumon : auscultation (examen clinique des poumons) (2) : Normale

Poumon (évaluation clinique) : signes fonctionnels (recherche gène à la respiration) : Aucun

Prélèvement nez (Résultat d'examen par prélèvement nasal (ex : recherche COVID)) : ???

Protides (2) (paramètre sanguin) : 69

Rx pulmonaire (2) (Radiographie pulmonaire) : ???

Sinus (examen de sinus nasaux) : ???

T.C.A. (paramètre sanguin) : 0.91

T.P. (paramètre sanguin) : 100

test allen droit (manœuvre clinique permettant de juger de la bonne perfusion de la main) : ???

test allen gauche (manœuvre clinique permettant de juger de la bonne perfusion de la main) : ???

Urée (paramètre sanguin) : 5

Antibioprophylaxie (dose d'antibiotique à réalisé au début de l'intervention servant à prévenir les infections) : poursuite cloxa

CISAI = supressif (avis CISAI : avis demandée aux maladies infectieuses)

Préméd J-1 (traitement à prendre le jour avant la date d'intervention) :
lovenox 0.2

Bilan complémentaire (bilan sanguins/ examens paraclinique fait à J-1 (ou à l'entrée) dans le service) : verifier groupe/RAI

Commentaires Remarques (commentaires diverses fait par le MAR à l'issue de la consultation) : Explication AG et ALR, patiente ok

Sexe féminin	(Item du Score APFEL Cf Supra)	: Oui
Non fumeur	(Item du Score APFEL Cf Supra)	: Oui
ATCD de NVPO	(Item du Score APFEL Cf Supra)	: Non
Analgésie morphinique (Score APFEL Cf Supra)	(Décrit l'utilisation de médicament dérivé de la morphine / Item du Score APFEL Cf Supra)	: Oui
texte asa	(Description du score ASA, Cf Supra)	: 1. Patient en bonne santé.

2. Patient présentant une atteinte modérée d'une grande fonction.

3. Patient présentant une atteinte sévère d'une grande fonction
qui n'entraîne pas d'incapacité.

4. Patient présentant une atteinte sévère d'une grande fonction,
invalidante, et qui met en jeu le pronostic vital.

5. Patient moribond, dont l'espérance de vie est inférieure à 24
heures, avec ou sans chirurgie.

Chirurgie à haut risque	(Item du score de Lee Cf Supra)	: Non
Cardiopathie ischémique	(Item du score de Lee Cf Supra)	: Non
ATCD insuf card congestive : Non	(Insuffisance cardiaque congestive / Item du score de Lee Cf Supra)	
ATCD d'AVC : Non	(Accident vasculaire cérébrale / Item du score de Lee Cf Supra)	
DID : Non	(Diabète insulino dépendant / Item du score de Lee Cf Supra)	
Créatinine>20.mg/DL(152µM)	(Paramètre biologique mesuré permettant d'estimer la fonction du rein/ Item du score de Lee Cf Supra)	: Non
medoc1	(médicaments, liste)	: Lovenox 0.4
	: cloxacilline	
poso2 2gx6/j	(posologie / Quantité et fréquence d'administration)	:
arret1	(Certains médicaments doivent être arrêtés avant une chirurgie, par exemple les médicaments fluidifiant le sang)	: Non

arret2 : Non

arret3 : Non

arret4 : Non

arret5 : Non

traitement : Non

CPT (Contrôle Pré-Transfusionnel) : inutile

GroupeRh (Groupe RHésus = carte de groupe sanguin) : 1ère et 2ème DTER
(détermination) à faire (2 déterminations sont à faire pour établir une carte de groupe sanguins)

Pfc (Plasma frais congelé / Fait partie des Produits Sanguins Labiles) : non
(peut être mise en réserve auprès de l'EFS (Etablissement Français du Sang))

Plaquette (Fait partie des PSL) : Aucune (mise en réserve ?)

RAI (Recherche Agglutinine Irrégulière/ Test sanguin réalisé afin de permettre la transfusion) : Extension à 21 jours possible (Généralement valable 3 jours, peut être étendu à 21 jours dans certaines conditions)

2. Cas 2 : Mr V C2 10/05/XX

Validation Cs : Oui

A JEUN Commentaire : stop aliùmentation (alimentation) : ITV (intervention) H-6
(Intervention Heure – 6 = arrêt de l'alimentation 6h avant opération.)

STOP boissons claires : ITV (intervention) H*2 (Stop boisson 2h avant l'intervention)

alcool : Non

allergies : Non Connue

année sevrage alcool : 2013

Score Apfel/Vpop : 1

Appareil auditif : Appareil bilatéral

Asa : 3

Atcd intubation difficile : ?

ATCD VAM difficile : ?

BMI : 28,07

Allergènes : RAS

Clinique : RAS

Commentaires intubation : ck 1 2019

Date intervention : 10/0X/202X

Date_ionogramme : 05/04/2023

Date_Plaquettes : 05/04/2023

DTM : > 65 mm

estomac plein : Non

Etat dentaire : Prothèse Haut/Bas/pas de mobilités dentaires

état veineux D : Bon

état veineux G : Difficile (Etat veineux mauvais de ce côté, donc privilégié la perfusion de l'autre côté).

Fc (Fréquence cardiaque) : 78

Geste opératoire : chirurgie pariétale (Eventration [avec plaque])

heure intervention : 1X:30

Informations Consentements : Technique d'Analgésie, Technique
d'Anesthésie, Transfusion, Intubation, Risque
Anesthésie, Risque Post-op, Risque Transfusion

Modalité : Réglée (chirurgie réglée = chirurgie programmée)

Intervenant : Dr XXX

Intubation difficile ? : Non

Lee : 1

Lentilles contact : Non

Mallampati : 1

Mecanisme IM : ????

Médecin Sénior : : Dr X

Morsure lèvre supérieure : Oui

ouverture de bouche : > 35 mm

PA : 135/82

piercing : Non

poids : 84,0

post-opératoire : Réanimation (Post opératoire prévu en réanimation chirurgicale)

Prieur : Non

Rachis cervical : souple

rgo : Non

RP : Normale

SaO2 : 99

Scanner/Echo : ???

VAM : 3

sevrage alcool : Oui

sevrage tabac : Non

sevrage toxicomanie : Non

tabac : Non

taille : 173

Terrain : RAS

Transfusion : Non

type d'anesthésie : AG
type intubation : IOT
VAM obésité : Oui
VAM ronflement : Non
VAM barbe : Non
VAM édentation : Oui
VAM âge>55 ans : Oui
Ventilation difficile : Non
PIT : 68,75
PC : 75,3052
CSA_sevrage_vapote : Non
CSA_tatouage : ?
CSA_sevrage_tabac : Non
CSA_sevrage_alcool : Non
Autres Examens :
Cavités droites (2) : Normales
Clairance créatinine (2) : 47
Coeur : auscultation (2) : souffle systolique connu
Coeur : signes fonctionnels (2 : met sup 4 - pas de sf thoracique
CRE (2) (compte rendu Echographie cardiaque Trans Thoracique (ETT)) : 26/04/2023

Ventricule gauche non dilaté avec une fonction contractile segmentaire et globale normale.
FEVG à 59 %. Débit cardiaque calculé à 6,6 l/min.
Aorte normale.
Valve aortique calcifiée . Rétrécissement aortique non serré. Gradient moyen VG-Ao à 19 mmHg. Insuffisance aortique minime (grade 1/4).
Valve mitrale normale. Absence d'insuffisance mitrale.
Oreillette gauche non dilatée.
Oreillette droite normale. Ventricule droit normal.
Absence d'HTAP. Valve tricuspide normale.

Insuffisance tricuspide minime (grade 1/4).

Absence d'épanchement péricardique.

Créatinine (2) : 132
E.C.G. : A faire - A voir
E.F.R. (2) : ???
F.E. (2) : 67,00
Fonction systol (2) : conservée
Hémoglobine (2) : 14.1
HTAP (2) : NON
HVG (2) : Non
K+ (2) : 4.8
Leucocytes (2) : 5600
Na (2) : 138
Echo cardiaque : Oui
Péricarde : Péricarde sec
Plaquettes : 160000
Poumon : auscultation (2) : Normale
Poumon : signes fonctionnels (: Aucun
Prélevement nez : ???
Rx pulmonaire (2) : ???
Sinus : ???
test allen droit : ???
test allen gauche : ???
texte libre Appareils : G15 orienté

Vit maritale

autonome à domicile

Urée : 7.0
Valve Aortique (2) : Normale
Valve mitrale (2) : Normale
VEMS % (2) : 104
VEMS ml (2) : 3040

VG (2) : Non dilaté

Conclusion : pas de syndrome restrictif

franche amélioration de la membrane alvéolo capillaire

avec DLCO corrigée à 81%

test de marche ne retrouve pas de désaturation

--> amélioration clinique et fonctionnelle post

pneumopathie COVID

Antibioprophylaxie : céfu 1.5g

Préméd J-1 (prémédication) : surveillance dextro (surveillance taux de sucre dans le sang)

protocole insuline

cellcept 500 2/0/2

crestor 10 0-0-1

pantoprazole 40 0/0/1

phosphoneuros 40 gouttes

Préméd J0 (prémédication) : cellcept 500 2/0/2

phosphoneuros 40 gouttes

advagraf 1.5 1/0/0

surveillance dextro

protocole insuline

Prescription : Bas de Contention

Commentaires Remarques : proposition théorique de péridurale thoracique (technique d'anesthésie loco-régionale), mais je redemande au chirurgien si il y a une indication sur l'éventration.

Pas dispo ajd (aujourd'hui), à revoir ultérieurement,

patient OK sur le principe, coag à vérifier

Sexe féminin : Non

Non fumeur : Oui

ATCD de NVPO : Non

Analgesie morphinique : Non

texte asa : 1. Patient en bonne santé.

2. Patient présentant une atteinte modérée d'une grande fonction.

3. Patient présentant une atteinte sévère d'une grande fonction
qui n'entraîne pas d'incapacité.

4. Patient présentant une atteinte sévère d'une grande fonction,
invalidante, et qui met en jeu le pronostic vital.

5. Patient moribond, dont l'espérance de vie est inférieure à 24
heures, avec ou sans chirurgie.

Chirurgie à haut risque : Non

Cardiopathie ischémique : Non

ATCD insuf card congestive : Non

ATCD d'AVC : Non

DID : Oui

Créatinine>20.mg/DL(152ùM) : Non

medoc1 : cellcept 500

poso1 : 2/0/2

: metformine 500

poso2 : 1-0-1

medoc3 : crestor 10

poso3 : 0-0-1

medoc4 : kardegic 75

poso4 : 0/1/0

medoc5 : pantoprazole 40

poso5 : 0/0/1

medoc6 : kenzen 4

poso6 : 1/0/0

medoc7 : phosphoneuros 40

poso7 : 1/1/1

medoc8	: advagraf 1.5
poso8	: 1/0/0
medoc9	: novonorm 1mg
poso9	: 1/0/0
arret1	: Non
arret2	: Non
arret3	: Non
arret4	: Non
arret5	: Non
traitement	: Oui
CPT	: inutile
GroupeRh	: 1ère et 2ème DTER conformes
nb PFC	: 0
nbr CGR	: 0
nbr plaquettes	: 0
Pfc	: non
Plaquette	: Aucune
RAI	: A faire à l'entrée